

14 - 06- TOXOPLASMOSE ET GROSSESSE - Pr. BASSIR

(0:00 - 0:14)

La deuxième infection, c'est la toxoplasmose et grossesse. C'est une maladie parasitaire liée à *Toxoplasma gondii*. 45% des femmes ne sont pas immunisées.

(0:16 - 0:34)

Chez un sujet qui n'est pas immunodéprimé, c'est une infection qui reste bénigne. La toxoplasmose congénitale, c'est quand même une infection qui est très rare, à peu près 1 à 2 cas au mille naissances. Elle est responsable de lésions sur le fœtus, en particulier neurologiques oculaires.

(0:36 - 0:57)

La séroconversion, elle concerne 5 000 femmes par an, à peu près 1% des grossesses. L'agent pathogène, c'est une parasite, c'est *Toxoplasma gondii*. Et la contamination est mais alimentaire, par l'ingestion de guisseries qui sont présentes dans la viande animale infectée.

(0:58 - 1:29)

Ou bien excrétées par les chats et contaminant l'eau ou souillant les végétaux et les fruits. Ou bien dans les terres de jardin, les litières de chats contenant des guisseries excrétées. Donc, la contamination se fait par l'ingestion de guisseries qui sont excrétées par les chats dans le sol.

(1:29 - 1:45)

Et donc, ils peuvent infecter soit les litières de ces chats, soit les légumes et les fruits. Soit ingérés par des animaux, les moutons, les vaches, les porcs. Et par la suite, de ces fruits.

(1:48 - 2:12)

Donc, l'homme peut ingérer ces guisseries par l'occasion de la consommation de la viande animale, des fruits et légumes. Ou bien par la manipulation des jardins et des litières de chats. La transmission materno-fœtale se fait au moment de la parasité mi-maternelle par voie hématogène transplacentaire.

(2:14 - 2:38)

La contamination fœtale peut être immédiate ou bien retardée par des micro-abcès qui restent présents dans le placenta. Comme pour la rubéole, le risque fœtale n'existe que lors d'un premier contact avec le parasite. Mais à l'inverse de la rubéole, le risque de transmission reste important pendant toute la durée de grossesse.

(2:38 - 2:56)

D'où l'intérêt de la prévention, de faire les serologies de façon régulière jusqu'à la fin de la grossesse. Le risque de transmission globale est de 30%. En prix conceptionnel, elle est de 1%.

(2:57 - 3:07)

Au cours du premier trimestre, elle est de 5 à 10%. Deuxième trimestre, de 20 à 25%. Troisième trimestre, elle est de 65 à 80%.

(3:10 - 3:34)

Le risque de contamination fœtale au cours du premier trimestre est de 5% avec des complications fœtales sévères. Au cours du troisième trimestre, le risque est de 72% à 36 semaines. Les complications innocentes moins sévères à rebuter sont les complications oculaires.

(3:35 - 3:58)

Le placenta constitue un réservoir et peut entraîner une contamination fœtale à distance de la primo-infection maternelle. Cela veut dire que le placenta est un réservoir même si la femme fait une primo-infection au cours du premier trimestre. Ce virus peut rester dans le placenta et contaminer le fœtus par la suite.

(3:59 - 4:15)

Les signes cliniques, c'est une maladie souvent inapparente. C'est une maladie qui est bénigne. La forme la plus fréquente, c'est la forme ganglionnaire sous forme d'adénopathie cervicale, postérieure, susclaviculaire, et immunitaire avec un syndrome fébrile moderne.

(4:17 - 4:39)

Anticancer, la sélective des anticorps. La première phase de latence, on a absence d'anticorps et cette phase de latence dure 8 à 10 jours après la contamination. La deuxième phase, c'est la présence d'IgM avec l'absence d'IgG qui dure quelques jours à quelques semaines.

(4:40 - 5:09)

La troisième phase, c'est l'apparition et l'augmentation du titre d'IgG avec présence d'IgM. La présence d'IgG affirme le diagnostic, ces IgG apparaissent en 2 à 3 semaines et leur titre augmente pendant 2 à 6 mois. Et la quatrième phase, c'est un titre stable d'IgG et la persistance d'IgM.

(5:09 - 5:29)

Le titre d'IgG reste en plateau plusieurs mois et leur décroissance est très lente. Et l'infection, ça signifie que l'infection remonte à plus de 2 mois. Et la cinquième phase, c'est la présence d'IgG à taux bas et stable sans IgM ou avec IgM résiduel.

(5:29 - 6:02)

L'infection à ce moment-là est ancienne ou bien des réactivations serologiques sont possibles. Comme on l'a vu sur le diapo, au début il y a l'apparition des IgA, des IgM puis des IgG. Par la suite, les IgA disparaissent en premier, puis les IgM et les IgG leur taux diminue jusqu'à ce qu'ils restent à un taux stable.

(6:03 - 6:29)

Les conséquences de la toxoplasmose sur la grossesse. Il y a un risque d'avortement spontané, il y a un risque de photopathie et surtout de la toxoplasmose congénitale neuro-oculaire. C'est une forme majeure et de sévérité importante avec des lésions de vascularites et de nécroses cérébrales.

(6:29 - 6:47)

On peut avoir des abcès, des calcifications, une dilatation ventriculaire, voire une hétérocéphalie. Les signes neurologiques. On peut avoir des convulsions, des troubles de tonus, hypo ou bien hypertonie et des troubles végétatifs.

(6:48 - 7:33)

Les signes oculaires, sous forme de necrophthalmie, de furieurisme pigmentaire caractéristique par sa gravité qui est liée à l'atteinte de la macula. Pour les formes viscérales, elles sont liées à une atteinte multisystémique de parasites, ictères, hépatosclerose mécanique, acides ou bien une myocardite. Il y a des formes inapparentes dont la traduction au départ est uniquement sérologique, sous forme d'une priorité limite périphérique, 50% de toxoplasmose congénitale et la révélation peut être tardive.

(7:35 - 7:45)

La conduite à tenir. Les formes enceintes qui sont séronégatives. Il faut préconiser des règles d'hygiène qu'il faut adopter dans leurs pratiques quotidiennes.

(7:46 - 8:03)

Il faut éviter tout contact avec les chats. Éviter de consommer de la viande mal cuite, donc il faut consommer de la viande bien cuite ou bien préalablement congelée. Il faut se laver les mains après avoir manipulé de la viande crue.

(8:05 - 8:24)

Ou bien le port des gants si on manipule, surtout si on a une clé sur la main pour manipuler de la viande crue. Il faut laver les fruits et les légumes et les consommer cuits ou pelés si possible. Et le port des gants pour jardiner.

(8:25 - 8:51)

Un contrôle mensuel de la sérologie est recommandé, bien sûr, en mentionnant la date de début de la grossesse pour le laboratoire. A l'accouchement, il faut contrôler la sérologie maternelle et la sérologie du centre du cordon. Il faut prévoir un contrôle un mois après l'accouchement pour ne pas méconnaître une contamination tardive.

(8:53 - 9:25)

Il est important en cas de grossesse de prescrire la sérologie le plus précocement possible. Idéalement, il faut connaître le statut sérologique avant la grossesse sans attendre la déclaration de la grossesse, car l'interprétation va être plus aisée. Et comme je reviens à ce que j'ai dit dans le cours de la rebelle grossesse, j'insiste sur l'intérêt de la consultation préconceptionnelle.

(9:26 - 9:48)

Il faut sensibiliser les femmes en âge de procréation de l'intérêt de la consultation préconceptionnelle. Pour l'interprétation des sérologies, IgG positif et IgM négatif. C'est une infection qui est ancienne, il faut demander un deuxième prélèvement si le premier a été réalisé tard.

(9:49 - 10:28)

Si les IgG sont négatifs et les IgM sont positifs, il peut s'agir d'une séroconversion au tout début ou bien d'une stimulation immunitaire polyclonale d'une virusse. D'où l'intérêt de demander une deuxième sérologie à trois mois, trois semaines plutôt plus tard, et discuter plus ou moins le traitement par l'accompagnement. Si les IgG sont positifs et les IgM sont positifs, si on a les tests précédents et sont négatifs, là, le diagnostic de séroconversion est sûr.

(10:29 - 10:52)

Si on n'a pas de statut connu, on peut parler soit d'un statut résiduel d'IgM, soit d'une séroconversion. Si la première sérologie est tardive ou bien un statut antérieur est inconnu, il faut doser l'avidité des anticorps pour dater l'infection. Refaire un prélèvement trois semaines après.

(10:53 - 11:11)

Si on a un taux d'IgG stable, ça veut dire que la séroconversion est ancienne. Si le taux est

ascendant, ça veut dire que c'est une séroconversion qui date de moins de deux mois. Si séroconversion.

(11:12 - 11:39)

Dès que l'infection maternelle est prouvée, il faut démarrer un traitement à base de rovanitine à raison de neuf unités par jour. C'est un traitement qui se fait du diagnostic jusqu'à l'accouchement. Le but de ce traitement, pourquoi cette durée de traitement, c'est de traiter la placentite maternelle, et essayer de diminuer le risque de transmission.

(11:39 - 12:01)

Parce qu'on a dit, le placenta constitue un réservoir, donc il faut traiter ce réservoir. Pour l'efficacité, il est modeste, ça n'empêche pas qu'il faut demander des sérologies sur les foetus à la naissance. Il faut établir une stratégie de diagnostic prénatale qui repose sur l'échographie.

(12:01 - 12:17)

Il faut rechercher des signes de photopathie, donc voir le cerveau. Est-ce qu'il y a des microplastifications, bien des images au niveau du cerveau. Voir est-ce qu'il y a une hépatose pneumécannique, ou bien un hydropse, un épanchement de tous les foetus.

(12:18 - 12:35)

Épanchement sous-cutané, péricardique, abdominal. La mise en évidence du parasite par un prélèvement du liquide amniotique à la recherche d'ADN par PCR. Ou par inoculation à la souris.

(12:35 - 13:06)

Donc c'est un test de référence, mais la réponse est généralement tardive, ça demande 4 à 6 semaines pour avoir une réponse. La myosynthèse, par la recherche de parasites par PCR dans le liquide amniotique, doit se faire à distance de la circumconversion, 4 semaines après, et après 18 semaines d'améliorer. Si la PCR est négative, on est sûr qu'il n'y a pas d'atteinte foetale actuelle.

(13:07 - 13:33)

Mais, il faut continuer la revalorisation jusqu'à la fin de la quarantaine. Faire une surveillance épidémiologique tous les mois, avec un prélèvement néonataux à la naissance, et un suivi pédiatrique jusqu'à disparition des antipores maternelles. L'affaire s'étudie quant à l'absence de l'infection néo-clinique, plus devant l'absence d'IgG à 1 an.

(13:34 - 14:12)

Les diagnostics prénatales positifs, c'est la toxotisme congénital, un foetus qui est infecté

avant 16 à 18 semaines d'améliorer, et on a une échographie rassurante. Le risque neurologique est majeur, et l'intention médicale de la grossesse peut être discutée. Interrompre la grossesse, ou bien poursuivre cette grossesse, il faut informer les patients du risque.

(14:13 - 14:41)

Mais ce qui est recommandé, ce qui est préconisé, c'est la poursuite de la grossesse. Et si on adopte une décision d'interruption médicale de la grossesse, il faut un accord de la patiente, et il faut un accord dans un centre pré-disciplinaire du diagnostic prénatal. Mais de plus en plus, ce qui est recommandé, c'est un traitement avec une poursuite de la grossesse et une surveillance échographique mensuelle.

(14:42 - 15:15)

Si le fœtus est infecté après 16 à 18 semaines d'améliorer, on ne fait plus d'IMG, il n'est pas systématique. Mais il faut donner un traitement soit par la diazine, la supradiazine, 50 mg par jour, plus le maloxyde, la périmétamine, 3 g par jour, ou bien avec la lederfoldine, 50 mg par semaine. Ce sont des cures de 4 semaines, alternées avec la rovanicilseuse pendant 15 jours, jusqu'à l'accouchement.

(15:15 - 15:29)

Ou bien, un autre protocole, c'est la fonzida, c'est la périmétamine plus la sulfa d'oxygène. C'est incomprimé 2 fois par semaine. Une surveillance foetale par échographique pendant 15 jours.

(15:30 - 15:49)

Une IMG peut être proposée si on a une anomalie évolutive, par exemple une grossesse d'aller majeure. La surveillance de la NFS 2 fois par semaine. Pour voir s'il y a une toxicité liée à l'utilisation d'un médicament.

(15:50 - 16:09)

Soit un agramme myocytose ou toxicité dermatologique. Et si on a des polynucléaires inférieurs à nos sens, on doit arrêter de fabriquer. La possibilité d'une infection congénitale avec un diagnostic anténatal négatif s'explique par le passage différent des toxoblastes.

(16:10 - 16:30)

Elle est asymptomatique dans plus de 90% des cas. D'où la nécessité d'une surveillance échographique anténatale et d'une surveillance postnatale. En postnatale, il faut un examen parasitologique du placenta.

(16:30 - 16:42)

Une sérologie sur le son de cordon et le son périphérique. Un examen clinique, un fond d'œil et un échotransplant fontanélaire. Un bilan anténatal et néonatal négatif.

(16:42 - 16:58)

On fait une surveillance sérologique une fois tous les 3 mois jusqu'à la négativation. Un bilan anténatal et néonatal positif. Il faut un traitement identique à la maman pendant un mois.

(17:00 - 17:15)

Un bilan clinique avec fond d'œil et un échotransplantanélaire. La prévention avant la grossesse. Connaître le statut immunitaire des femmes.

(17:16 - 17:31)

Pendant la grossesse, il faut faire une surveillance sérologique. Surtout les femmes à risque sont les femmes séro-négatives. Une fois tous les mois et les derniers tests se font après l'accouchement sur du son périphérique.

(17:32 - 17:38)

Il faut suivre les précautions pour la femme enceinte séro-négative. Sous-titres réalisés para la communauté d'Amara.org